

■ 制度／令和9年度介護報酬改定

介護報酬改定の視点案、生活期リハの推進を明記

令和9年度改定の5つの基本的な視点 「自立支援・重度化防止」は独立項目から外れる

厚生労働省は9月30日の社会保障審議会・介護給付費分科会(第268回)で、令和9年度介護報酬改定の「基本的な視点」案を示した。視点は5つで、①物価・賃金の上昇への対応と処遇改善、②人口減少に対応したサービス提供体制、③地域包括ケアシステムの深化、④現場環境の改善とサービスの質の向上、⑤制度の持続可

能性の確保、という並びだ。リハビリに関わるのは③の中身である。「生活期における自立支援に向けたリハビリテーションを一層推進」と明記され、「状態の維持・改善」「生活の質の向上」、LIFE(科学的介護情報システム)の活用も位置づけられた。一方で、過去3回の改定で独立した柱だった「自

立支援・重度化防止」は、今回は見出しから外れた。委員からは、リハビリだけで地域包括ケアの深化を代表できるのかとの疑問も出た。全国市長会は介護予防の明記を求めた。ここで示されたのは方向性で、個別の単位数や算定要件は今後の審議で決まる。



視点の並びが変わったことを、まず押さえておきたい

出典 [PT-OT-ST.NET・POST](#)

数字で見る

5つ

基本的な視点案の数

268回

介護給付費分科会の回数

3回

独立項目だった過去の改定数

■ 脳卒中／体性感覚

体性感覚への介入、バランスは改善も上肢では有意差なし

固有受容覚トレーニング、局所振動、温熱などを従来療法と比べた。統合できた Berg Balance Scaleは体性感覚介入のほうが有意に良好だった一方、上肢のFugl-Meyer評価(FMA-UE)とARATには有意な統合効果がなかった。記述的な整理では、固有受容覚トレーニングが感覚と下肢機能、局所振動が上肢運動機能の改善と関連した。

偏りのリスクは「懸念あり」から「高い」まで



で、介入内容もばらばら。長期効果を調べた試験は2件だけで、判断できない。著者も「決定的な結論は出せない」とする。バランスには期待できそうだが、上肢は未確定という整理になる。

出典 [NeuroRehabilitation](#)

■ 脳卒中／転倒予防

脳卒中後の転倒予防運動、転倒率は下がる傾向も確定せず

転倒の発生率は運動群で低い傾向だったが(IRR 0.84、95%CI 0.62～1.15)、信頼区間が1をまたぎ、効果なしの可能性が残る。1回以上転倒した人の割合は変わらず(RR 0.98、95%CI 0.81～1.18)、歩行速度は平均0.04 m/sの小さな改善だった(95%CI 0.01～0.07)。

試験は3件と少なく、運動どうしを比べた試験はない。著者の結論は「転



倒率を下げる示唆はあるが、転倒する人の数には影響しない」。運動だけで転倒をなくせるとは言えず、生活環境の調整などと合わせて考える材料になる。

出典 [Clinical Rehabilitation](#)

短 信

〈脳卒中〉**rTMSと鏡療法の併用、上肢が改善**

RCT7件402人のメタ解析。FMA-UEとBBTが改善したが最適な条件は不明で慎重な解釈が必要 出典 [Neurol Sci](#)

〈呼吸リハ〉**COPDの体重、退院後も維持も栄養指導は減**

入院呼吸リハ75人。体重57.7→60.6kgと維持したが、退院後の栄養指導は追跡時21%に低下 出典 [Respiration](#)

〈若年脳卒中〉**18～45歳の脳卒中、役割や就労に影響**

スコーピングレビュー15件。親・配偶者・就労など、人生の役割づくり全体が損なわれると整理 出典 [Am J Occup Ther](#)

〈在宅〉**間質性肺疾患の在宅呼吸リハ、効果は小さめ**

南インド単施設のRCT。6分間歩行とK-BILDは改善したがMCID未達、MCID達成割合はRR 2.32 出典 [Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis](#)

〈心臓リハ〉**がん患者の在宅心臓リハ型運動、体力が向上**

RCT9件632人のメタ解析。心肺体力SMD 0.42、QOL SMD 0.63。安全性の報告は不十分 出典 [Ann Med](#)

〈目標設定〉**脳卒中リハの目標設定、臨床家の視点を統合**

質的研究8件・臨床家108人。指示的と協働的の型、希望と現実の葛藤、本人から始める姿勢が論点 出典 [Clin Rehabil](#)

〈嚥下〉**脳卒中後の女性、嚥下リスクで骨盤底症状強い**

トルコの71人の横断研究。嚥下障害リスクあり31人でTUGも遅く、尿失禁と独立に関連 出典 [Int Urogynecol J](#)

〈動作観察〉**動作観察療法の脳波指標を22件で整理**

ミュー・ベータ帯のERDが反応の指標となり、FMAなどの改善と相関。ただし手法は不統一 出典 [Ann Biomed Eng](#)